



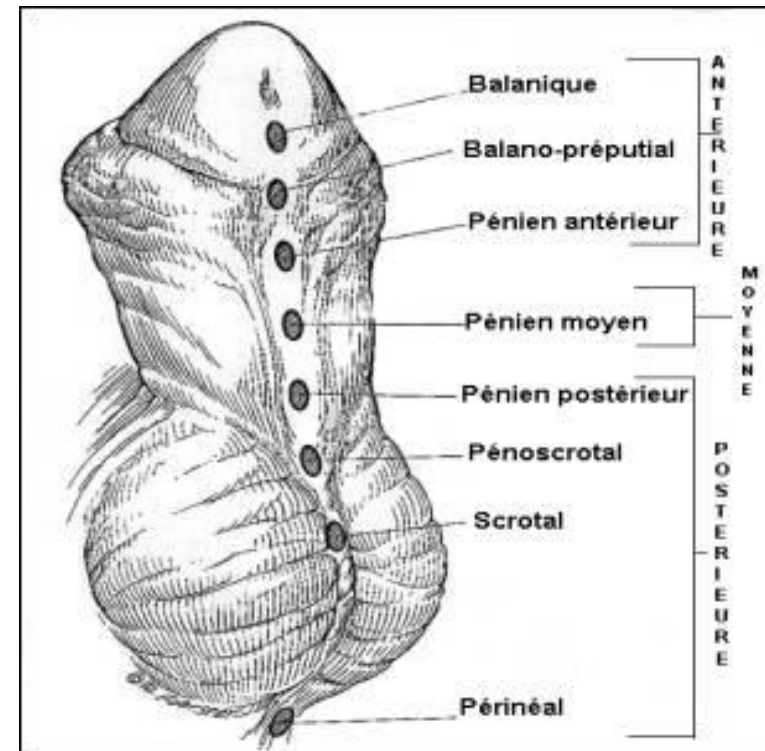
MALFORMATIONS DE L'URÈTRE

HYPOSPADIAS

Définition- ouverture de l'urètre sur la face inférieure du pénis;

Fréquence de 1,5%;

Pathogénie: l'anomalie se produit par **résorption de la lame urétrale** du tubercule génital et par **absence d'union entre les plis génitaux** (dysraphisme) au niveau du sinus uro-génital





MALFORMATIONS DE L'URÈTRE

Clinique:

- avec l'ouverture abérente du méat urétral s'associe d'autres lésions dans le contexte d'une aplasie régionale de la face ventrale du pénis:
- tégument préputiel en excès, sous forme d'un tablier qui couvre la face dorsale du gland;
- le gland est aplati;
- le méat hypospadié est souvent sténosé, ponctiforme;
- le gland est lié au méat par une bande fibreuse qui détermine le coudage et le raccourcissement du pénis;
- existe divers grades de torsion latérale du pénis





MALFORMATIONS DE L'URÈTRE

Anatomo-pathologie:

- en fonction de l'endroit d'ouverture de l'urètre, on distingue plusieurs formes:

Hypospadias balanique:

- forme la plus fréquente et bénigne;
- le méat urinaire s'ouvre au niveau du sillon balanique et est très souvent fibrose et ponctiforme;
- le tablier préputial dorsal est présent mais sans courbure du pénis;
- le jet urinaire est filiforme.



tégument préputiel

méat physiologique

méat hypospadié

le coudage

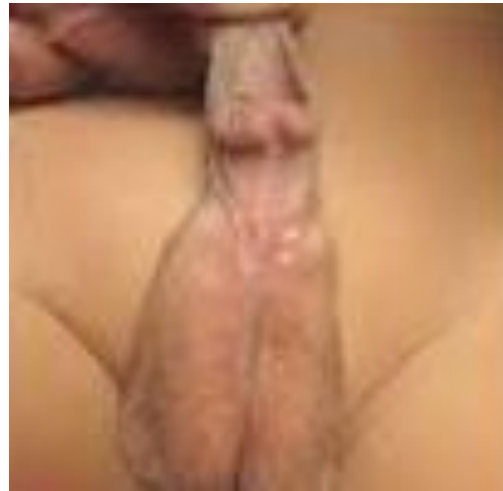


MALFORMATIONS DE L'URÈTRE

Anatomo-pathologie:

Hypospadias pénien:

- en fonction de la localisation du méat se subdivise en :
- antérieur;
- intermédiaire;
- postérieur.
- s'accompagne de coudures, palmures, rétractions, rotations péniennes.





MALFORMATIONS DE L'URÈTRE

Anatomo-pathologie:

Hypospadias péno-scrotal et scrotal:

- l'urètre s'ouvre au niveau de la racine du pénis ou entre les bourses scrotales;
- le scrotum apparaît divisé par un sillon médian au niveau duquel s'ouvre l'urètre;
- les testicules sont d'habitude cryptorchidies ou ectopiques;
- le pénis apparaît rudimentaire, rétracté au niveau du sillon;
- le tablier préputial est analogue à un clitoris;
- porte aussi le nom d'hypospadias vulviforme et mène à des confusions lors de l'établissement du sexe;
- les enfants plus grands ne peuvent uriner qu'en position assise.



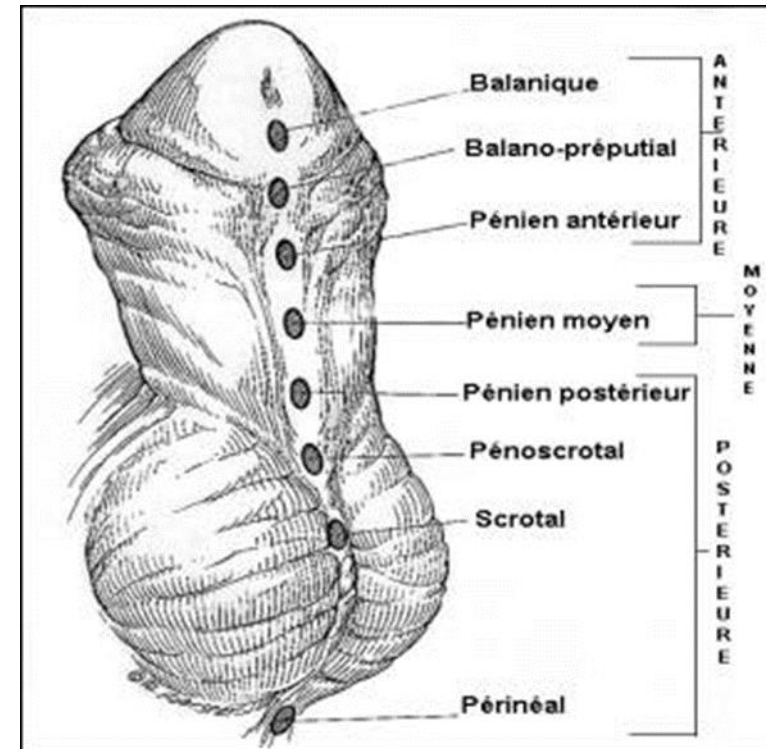


MALFORMATIONS DE L'URÈTRE

Anatomo-pathologie

Hypospadias périnéal:

- l'urètre s'ouvre au niveau du périnée antérieur sur la ligne ano-scrotale;
- le plus grave et difficile à traiter.





MALFORMATIONS DE L'URÈTRE

Traitement:

- vise le redressement de la forme du pénis et la confection d'un néo-urètre afin d'obtenir une miction, érection et éjaculation physiologiques;
- est étapisé en fonction de la forme anatomo-pathologique et de l'âge de l'enfant:

Recalibrage du méat hypospadié sténosé:

- se fait chez le nouveau né ou le petit nourrisson, pour anticiper les conséquences d'un obstacle sous vésical sur l'arbre urinaire.

Correction des vices morphologiques du pénis:

- se fait autour de l'âge de 2 ans.

Urétroplastie:

- s'effectue par de multiples procédures à l'âge de 6 - 7 ans.
- il est recommandable de finaliser le traitement jusqu'à l'âge de scolarisation pour diminuer les complexes psychiques, qui peuvent s'accroître lors de l'entrée dans la collectivité.



MALFORMATIONS DE L'URÈTRE



SPITALUL CLINIC DE
URGENȚĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



MALFORMATIONS DE L'URÈTRE

ÉPISPADIAS

Définition

- se caractérise par l'ouverture de l'urètre sur la face dorsale du pénis;
- est beaucoup plus rare que l'hypospadias, mais plus grave comme pronostique;

Fréquence

- apparaît à une fréquence de 1/30.000 naissances





MALFORMATIONS DE L'URÈTRE

Anatomo-pathologie

- le pénis est hypoplasique, quelques fois réduit à un gland caché dans un sillon;
- existe quatre variétés anatomiques:

Épispadias balanique:

- l'urètre s'ouvre sur la face dorsale du sillon balano-préputial.

Épispadias pénien:

- le méat s'ouvre sur la face dorsale du pénis entre le gland et la racine du pénis





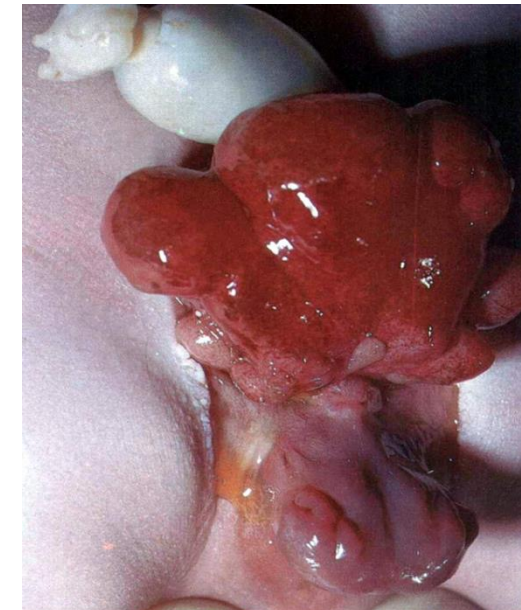
MALFORMATIONS DE L'URÈTRE

Anatomo-pathologie

Épispadias sous-pubien;

Épispadias vésical.

- les deux derniers sont des extrophies vésicales inférieures avec incontinence urinaire.
- l'examen du malade va établir la gravité des lésions et l'existence d'une incontinence urinaire qui est quelques fois partielle

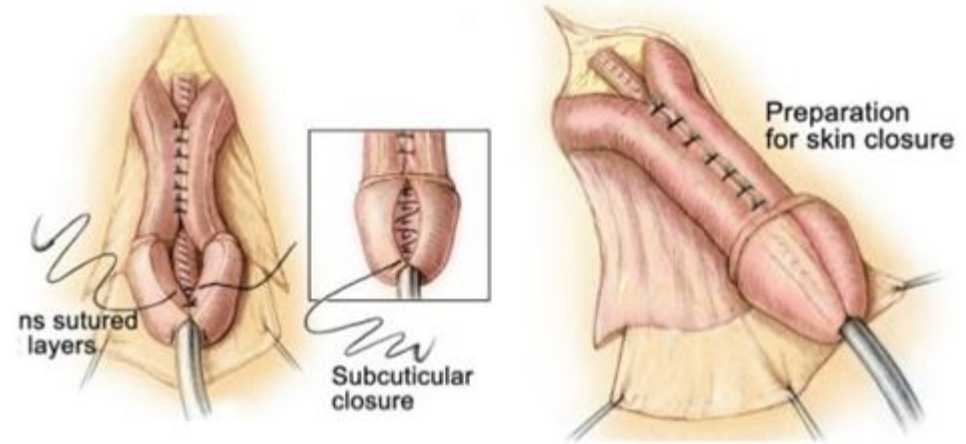




MALFORMATIONS DE L'URÈTRE

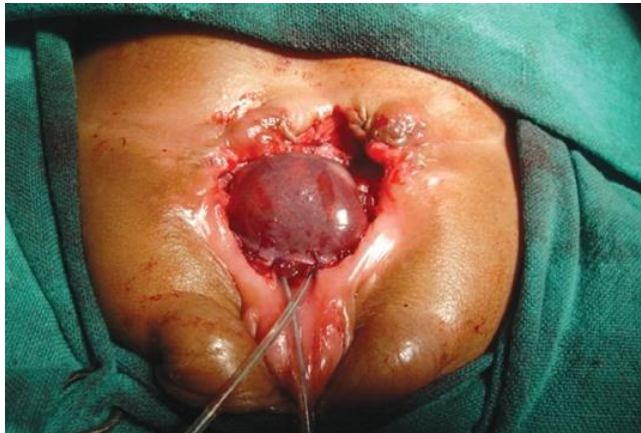
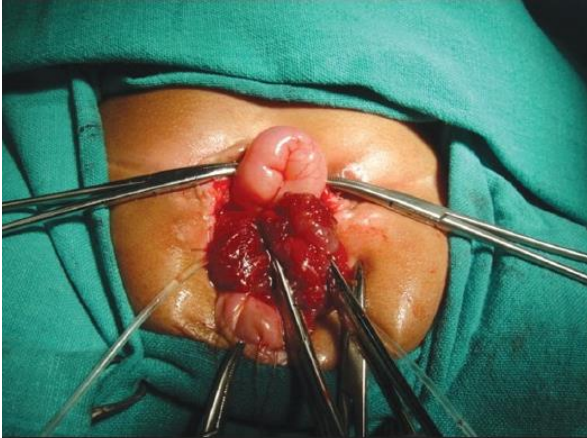
Tretement:

- est chirurgical et à comme objectif:
- le redressement du pénis;
- la reconstruction de l'urètre;
- l'élimination de l'incontinence
- **Dans l'épispadias continent:**
 - urétroplastie des téguments péniens;
 - se suppriment les tissus fibreux qui unissent le pénis au pubis.
- **Dans l'épispadias incontinent:**
 - se réalise la continence par reconstruction du col vésical (opération Young);
 - urétroplastie.





MALFORMATIONS DE L'URÈTRE





MALFORMATIONS DE L'URÈTRE

MALADIE DU COL VÉSICAL (MALADIE MARION):

- est plus fréquente chez les garçons (4/1);
- représente un défaut primitif, congénital de l'ouverture du col vésical (dysectasie).

Pathogénie:

- n'est pas clairement établie;
- d'après Marion est analogue à la sténose hypertrophique du pylore;
- d'après Kerneis - cardio-spasme.

Tableau clinique:

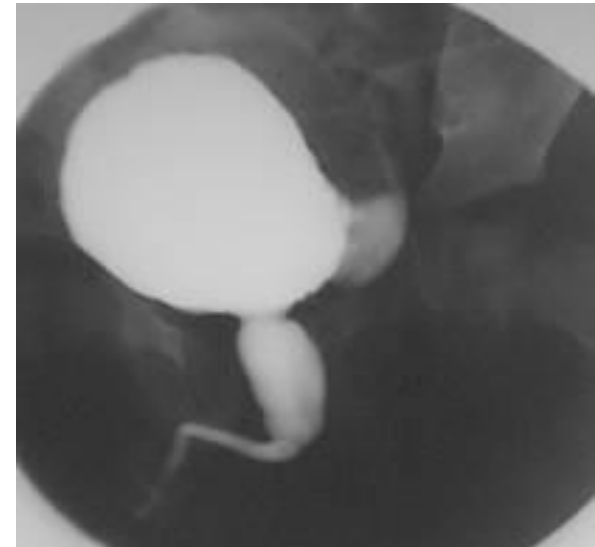
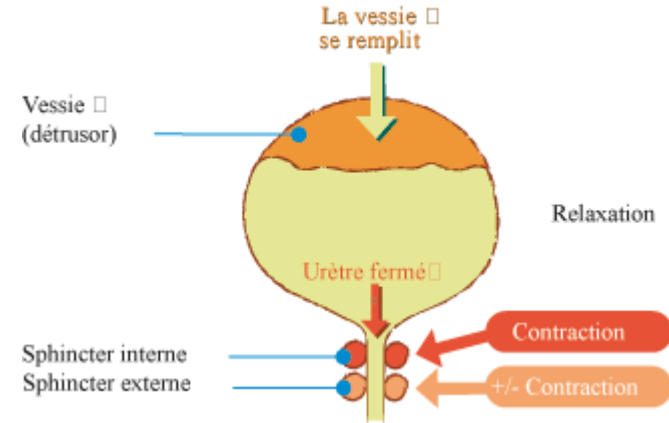
- infections urinaires récidivantes ou chroniques;
- troubles mictionnels sous forme de polaki-dysurie,
- rétention aiguë d'urine.



MALFORMATIONS DE L'URÈTRE

Diagnostic positif:

- sur la symptomatologie décrite;
- sur la base des examens de laboratoire (uro-culture positive, albuminurie, rétention azotée, anémie);
- examen radiologique:
- l'urographie précise l'état fonctionnel du rein;
- la cysto-urétrographie mictionnelle sériée – d'élection, surprend l'étranglement concentrique du col vésical, surtout dans l'étape pré-mictionnelle.





MALFORMATIONS DE L'URÈTRE

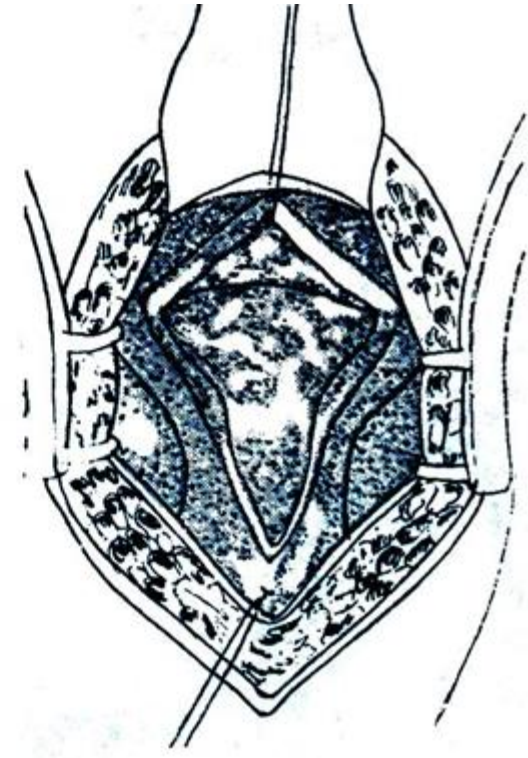
Traitement:

Médical:

- dans les formes légères;
- surtout antimicrobien pour assainir l'infection urinaire.

Chirurgical:

- dans les formes graves;
- consiste surtout en une plastie du col vésical en YV (Young), avec bons résultats post-opératoires.





MALFORMATIONS DE L'URÈTRE

VALVES DE L'URÈTRE POSTÉRIEUR

Définition

- sont des plis de la muqueuse urétrale;
- fonctionnel : réalise une obstruction sévère sous-vésicale avec répercussions graves sur l'appareil rénal;
- semblent être dues aux vestiges d'une membrane uro-génitale et aux canaux Wolffien.





MALFORMATIONS DE L'URÈTRE

Anatomo-pathologique:

- d'après Young : 3 variantes:

a. valve sous-montanale (en nid d'hirondelle) située sur les parois latérales de l'urètre postérieure;

b. valve supra-montanale sur les parois urétrales latérales, juste sous le col vésical;

c. valve en diaphragme supra- ou sous-montanale



sous-montanale,



supra-montanale



diaphragmatique.



MALFORMATIONS DE L'URÈTRE

Formes cliniques:

1. **Forme néonatale et du nourrisson:** est grave, avec
 - état général altéré,
 - fièvre,
 - retard staturo-pondéral,
 - troubles digestifs (anorexie, vomissements, diarrhées);
 - dysurie importante,
 - souvent globe vésical;
- **Para-clinique** apparaissent -l'anémie et la
 - rétention azotée;
- **Diagnostic** prénatal par ultra-sono-graphie



MALFORMATIONS DE L'URÈTRE

Formes cliniques:

2. forma clinique du grand enfant:

- est plus rare, se manifeste par:
- polaki-dysurie;
- rétention d'urine ou incontinence urinaire par sur plein;
- jet urinaire filiforme.
- reflux vésico-urétéral secondaire : entraine des phénomènes de pyélonéphrite ;

3. forme clinique mineure:

- symptomatologie dysurique effacée;
- infection urinaire récidivante;
- insuffisance rénale chronique à l'âge de l'adolescence



MALFORMATIONS DE L'URÈTRE

Diagnostic:

- l'**urographie** permet l'appréciation de l'état morpho-fonctionnel des reins;
- la **cystographie mictionnelle** sériée avec incidence de profil met en évidence la présence des valves sous la forme d'un contour semi-circulaire, unique ou double, avec convexité inférieure.



Cysto-urétrographie mictionnelle: pseudo-diverticules vésicaux, hypertrophie du col (flèche vide), dilatation de l'urètre postérieur et image «en coup d'ongle» caractéristique de VUP (flèche pleine). Le reflux vésico-urétéral souvent associé manque ici



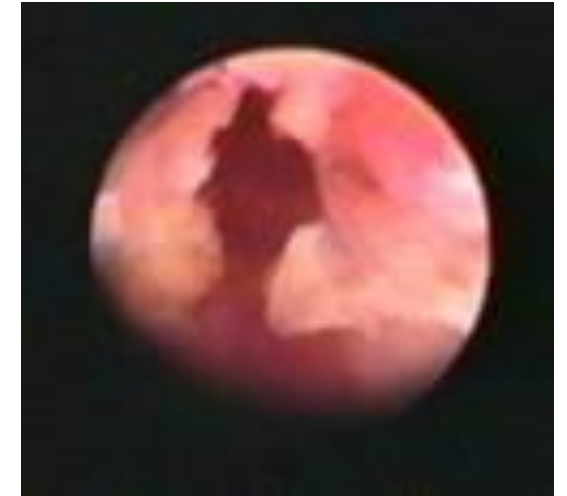
MALFORMATIONS DE L'URÈTRE

Traitement:

- résection des valves par cysto-urétrotomie ou endoscopique (fulguration);
- correction des lésions secondaires associées (plastie du col vésical, réimplantation des uretères, etc.).



Valve; Cystoscopie



après fulguration

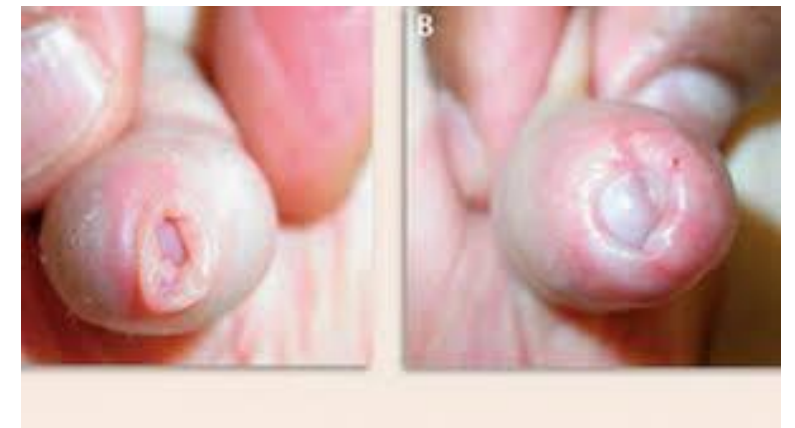


MALFORMATIONS DE L'URÈTRE

PHYMOSE

Définition:

- se caractérise par l'impossibilité à décalotter le gland après l'âge de 2 ans, à cause d'un anneau fibreux préputial;
- chez le nourrisson et le petit enfant, l'orifice préputial est étroit physiologiquement, mais s'il n'y a pas de phénomènes inflammatoires locaux, il se dilate progressivement jusqu'à l'âge de 2 ans permettant un décalotage facile;
- l'affection peut être la conséquence d'une balano-postite répétée ou à des manœuvres intempestives de décalotage avec production d'une fissure préputiale cicatrisée avec sténose;





MALFORMATIONS DE L'URÈTRE

PHYMOSE

- la phimose congénitale s'associe souvent à un **excès préputial** « en museau de tapir »;
- sa présence mène à des **troubles dysuriques**, des infections locales et ascendantes;
- chez les enfants plus grands, elle réalise un obstacle sous-vésical qui peut générer un **reflux vésico-urétéral** et des **infections urinaires récidivantes** ;
- chez l'adulte elle constitue un facteur de **dyspareunie et d'impotence sexuelle**.





MALFORMATIONS DE L'URÈTRE

Diagnostic différentiel:

Adhérences balano-préputielles:

- consistant en une coalescence laxe entre l'épithélium glandulaire et la muqueuse préputielle;
- fréquente chez les garçons sous 2 ans;
- dans 80% des cas sont congénitales et dans 20% sont secondaires aux infections locales répétées, sur un fond d'hygiène déficitaire;
- favorise le dépôt de smegma dans le sillon balano-préputiel et prédispose aux supra-infections;
- bénéficie d'une lise légère, décalotage, élimination de la smegma et application locale d'onguents avec antibiotiques.





MALFORMATIONS DE L'URÈTRE

Complications:

Balanite -inflammation de la muqueuse du gland pénien;

Balano-postite -infection de la muqueuse préputiale et de la muqueuse du gland pénien;
- les deux s'installent sur le fond d'existence d'un espace virtuel balano-préputiale avec déficit consécutif de l'hygiène locale.

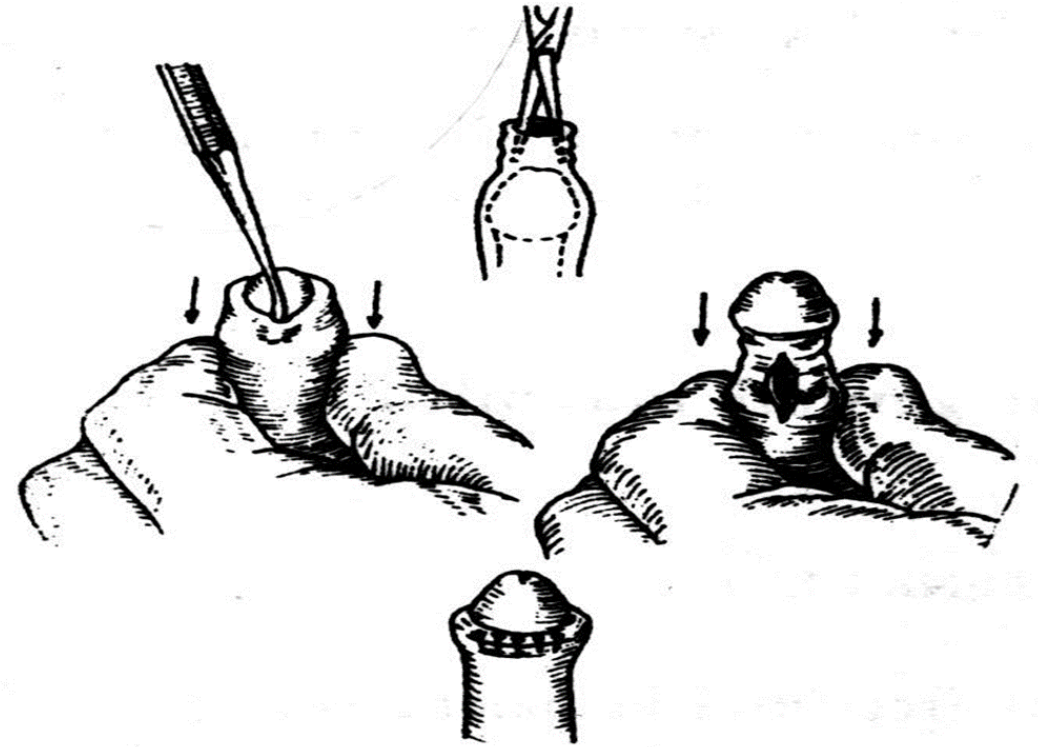




MALFORMATIONS DE L'URÈTRE

Clinique: -douleurs locales,
-œdème inflammatoire,
-troubles dysuriques,
- fièvres ,
prédisposent aux infections urinaires ascendantes;

Traitement: débridage locale, lavement avec solutions antiseptiques faibles, application d'onguents avec antibiotiques ;
- après recul des phénomènes inflammatoires on apprécie l'opportunité de phymotomie. Duhamel



Phymotomie. Duhamel



MALFORMATIONS DE L'URÈTRE

Paraphymose:

- apparaît par décalotage forcé, quand l'anneau phymotique scléreux comprime le sillon balano-preputial et empêche le recalotage du gland;
- se produit une stase lympho-veineuse avec œdème massif du gland et du prépuce;
- négligé, mène à la nécrose du prépuce et du gland;



compression et prolongée du prépuce



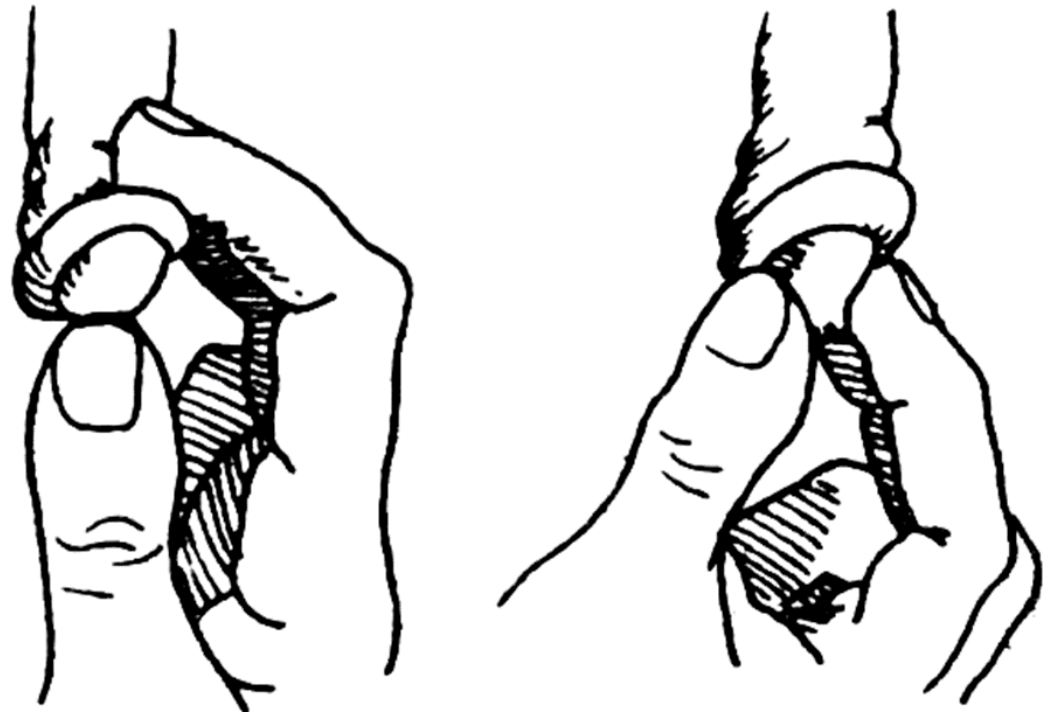
MALFORMATIONS DE L'URÈTRE

Clinique:

- douleurs locales violentes;
- phénomènes dysuriques jusqu'à la rétention aiguë d'urine.

Traitement: - est une urgence, et consiste en:

- compression légère et prolongée du prépuce pour réduire l'œdème;



Technique de réduction de la para-phymose